

燥湿化痰,痰祛则肺道通畅,有利于哮喘康复。笔者选择哮喘缓解期为切入点,依照中医理论,结合现代免疫学观点,从肺、脾、肾入手,采用益气、健脾、补肾、活血的治法,通过改善患者的临床症状,调整和增强机体免疫功能,从而达到痰消喘平、邪去正复之目的。

(收稿日期 2004-06-14)

杏贝黛蛤散治疗 慢性支气管炎 28 例

范云鹏

(内蒙古赤峰市喀喇沁旗医院,024400)

近年来,笔者采用民间验方杏贝黛蛤散治疗慢性支气管炎 28 例,效果满意,现报告于下。

一般资料

本组慢性支气管炎患者 28 例,其中男 15 例,女 13 例;年龄 9~74 岁,平均年龄 52 岁;病程 4~18 年,平均 8.5 年;合并肺气肿者 5 例。患者临床均以长期反复发作咳嗽、咯痰或伴有喘息为主要表现,每次发作时间都在 2 个月以上,并有连续 2 年以上病史,轻者仅在晨起及晚睡时上述症状较为明显。咳嗽、咯痰或喘息在急性发作期明显加重,短期内出现脓性或黏液性痰,痰量明显增加,可伴有发热及其他炎性表现。本组患者已排除心肺及其他疾病引起者。

治疗方法

除对 8 例急性发作期患者配用西药外,全部患者均采用杏贝黛蛤散治疗。方剂组成与制备:杏仁 40g,川贝母 60g,海蛤壳粉 120g,粳米 120g,青黛 20g。先将杏仁、川贝母装入新鲜猪或牛胆内,置阴凉干燥处 14 天后,取出胆内药物晾干。海蛤壳粉、粳米二味入锅内炒,至将粳米炒熟。四味共研细末,加入青黛拌匀即为杏贝黛蛤散。每次服 5g,每日 3 次,米汤送服,亦可装入空心胶囊内服用。1 个月为 1 个疗程,共服 1~2 个疗程。对本组患者随访 3 年。

治疗结果

疗效评定标准:痊愈:咳嗽等诸症悉平,3 年未复发;显效:诸症消失,虽有再次复发,但症状轻微,发病持续时间少于 10 天;有效:诸症消失,再次复发时症状较前为轻,发作持续时间少于 30 天;无效:诸症无明显改善或有所改善,复发时症状如初,

发作时间仍在 2 个月以上。

本组 28 例经治疗均获效,其中痊愈 21 例(75.0%),显效 5 例(17.9%),有效 2 例(7.1%)。

典型病例

张某,男,77 岁,蒙族,离休干部,2000 年 8 月 2 日初诊。患者咳嗽、咯痰、喘息已 17 年,每逢冬春两季发病,每次发病均迁延 2 月以上。平素也不时有咳嗽、喘息症状。1984 年被确诊为慢性支气管炎。曾用过多种中西药物治疗,效果不佳。近半月来,咳喘加重,咳痰不畅,时有发热,夜间尤甚,不能平卧,咳大量白稀痰,且伴有头痛、头晕、心悸、气短、乏力、周身酸痛、大便干燥、小便黄赤等症状。曾服用青霉素 V 钾片、强的松片、氨茶碱片等药,非但无好转,病情反有加重。观其两目无神、精神疲惫、面目虚浮、面色萎黄,舌淡苔白腻,脉沉而微滑。X 光胸透提示慢支合并肺气肿。血常规化验:WBC $12.0 \times 10^9/L$ 。诊断:慢性支气管炎合并肺气肿。即予杏贝黛蛤散,同时给青霉素钠 640 万^U、利巴韦林注射液 0.4g、地塞米松 5mg,加入 250ml 生理盐水中静滴,每日 2 次。3 日后咳嗽大减,咯痰已爽,已能平卧,不发热,精神转佳。继续给杏贝黛蛤散口服,静滴液中减地塞米松,继续用 1 周后,咳喘不作,饮食大增,二便正常,除稍感乏力外一如常人。停用输液,继续服用杏贝黛蛤散 2 个疗程后,改服香砂养胃丸、金匱肾气丸 2 个月。3 年后随访患者诉一直未复发。

讨论

慢性支气管炎是一种常见病、多发病,可发生在任何年龄,多由急性期失治而致。发病每与季节、气候有关,尤其在北方寒冷地区多见。本病以反复发作、病程长为特点,治疗颇难。止咳、祛痰、平喘、控制感染、菌苗注射等方法虽然有效,大多不能根除。按中医辨证本病属本虚标实之证,在治疗中应分清标本、缓急施治。根据肺的生理功能及病理特点,本病的发病病位在肺系,而脾肾气虚乃是本病反复发作的重要原因。因此在治疗中,缓解期应给予补脾、益肾等品。

杏贝黛蛤散方中杏仁、川贝母以胆汁浸泡既能止咳平喘、化痰清肺又能清热解毒;《本经》中称海蛤壳能“治水气浮肿,利小便,治咳嗽上气”。本方在配方中照顾到了脾胃功能,用大量的炒粳米粉及米汤调服,在补脾和胃同时也能缓解寒凉药物及贝壳类药物对胃气的损伤。本方清而不寒,苦不伤气,不失为治疗慢性支气管炎的好制剂。应用本方治疗慢

性支气管炎时不排除缓解期配用健脾、补肾等方法及急性发作期配用西药抗炎、止咳、平喘、化痰等疗法。

(收稿日期:2004-06-21)

健脾化痰汤治疗非胰岛素 依赖性糖尿病 30 例

张洪俊

(江苏省建湖县人民医院,224700)

非胰岛素依赖性糖尿病(NIDDM)是糖尿病最常见的类型。据世界卫生组织(WHO)统计,NIDDM 患者已占糖尿病人的 85%左右,且有逐年上升趋势。我们自 1993 年~2003 年 3 月采用健脾化痰汤治疗 NIDDM 患者 30 例,疗效满意,现报道如下。

一般资料

全部病例均为门诊患者,均符合 WHO 推荐的糖尿病诊断标准(胡莫华,贾刚田编译。《糖尿病及其主要并发症》。北京:中国环境科学出版社。1990:12~15)。将全部患者随机分为 2 组。治疗组 30 例,男 13 例,女 17 例;年龄最大 70 岁,最小 32 岁,平均 51.2 岁;病程最长者 12 年,最短者 5 个月。对照组 30 例,男 16 例,女 14 例;年龄最大者 72 岁,最小者 34 岁,平均 52.6 岁;病程最长者 11 年,最短者 6 个月。两组在年龄、病程、空腹血糖、血脂、血液流变学等方面经统计学处理,无显著性差异,具有可比性($P>0.05$)。两组病例均无严重心、肝、肾功能不良者,排除酮中毒、酸中毒者。全部病例经降糖药控制空腹血糖均低于 14.0mmol/L。

治疗方法

治疗组:用自拟健脾化痰汤:黄芪 30g、党参 15g、苍术 15g、元参 15g、山药 20g、丹参 15g、三七粉 5g(冲服)、桃仁 10g、水蛭 5g。每日 1 剂,水煎分 2 次口服。同时每日服用达美康(法国施维雅药厂、

天津华津制药厂联产)80mg。对照组:单服达美康,每日 80~160mg,最大量 240mg。治疗期间两组均停用其他降糖药物。以 1 个月为 1 个疗程,连续治疗 2 个疗程后评定疗效。

治疗期间每周测 1 次空腹血糖(微柱法),治疗前后分别测定血液流变学指标(用 R₈₀型微电脑椎板式粘度计)和血脂(酶标法),进行统计分析。

治疗结果

疗效评定标准:显效:症状明显改善或消失,FBG 恢复正常或较治疗前下降 $\geq 30\%$;有效:症状改善,血糖下降 $\geq 20\%$,但不足 30%;无效:症状减轻,或不变,或加重,血糖下降 $< 20\%$ 。

治疗结果显示治疗组 30 例中,显效 19 例(63.33%),有效 9 例(30%),无效 2 例(6.67%),总有效率 93.33%;对照组 30 例中,显效 16 例(53.33%),有效 8 例(26.67%),无效 6 例(20%),总有效率 80%。两组总有效率比较差异有显著性($P<0.01$)。

治疗组和对照组治疗前空腹血糖(mmol/L)分别为 9.98 ± 2.12 和 9.15 ± 2.11 ,治疗 2 个疗程后分别降至 6.41 ± 2.23 和 7.32 ± 2.26 。治疗前治疗组血脂指标中 Tch、TG 及 HDL-C 分别为(mmol/L) 6.38 ± 0.86 、 2.35 ± 0.83 和 1.21 ± 0.22 ,治疗后分别为 5.84 ± 0.76 、 1.93 ± 0.78 和 1.31 ± 0.24 ,与治疗前比较,Tch、TG 显著下降;HDL-C 则有明显上升,均有显著性差异($P<0.05$)。对照组的血脂相应指标则由治疗前的 6.30 ± 0.74 、 2.01 ± 0.84 和 1.15 ± 0.23 ,改变为治疗后的 6.12 ± 0.66 、 1.79 ± 0.77 和 1.22 ± 0.24 ,治疗前后比较均无显著性差异($P>0.05$)。

治疗前后血液流变学变化详见表 1。治疗组治疗后血液流变学指标较治疗前均有明显改善,差异显著($P<0.05$ 或 $P<0.01$);而对照组仅高、低切全血比粘度改变及血浆比粘度差异有显著性($P<0.05$),且其前 2 项指标的改善程度均低于治疗组,有显著性差异($P<0.05$ 或 $P<0.01$)。

表 1 两组治疗前后血液流变学指标变化比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	n	全血比粘度(比)		血浆比粘度 (mPa·S)	RBC 聚集指数	RBC 比较(%)
		高切变率	低切变率			
治疗组						
疗前	30	7.70 ± 1.08	12.65 ± 1.16	1.98 ± 0.25	2.51 ± 0.56	0.53 ± 0.02
疗后	30	$5.51 \pm 0.85^{**\Delta}$	$10.22 \pm 1.01^{**\Delta}$	$1.83 \pm 0.15^*$	$1.94 \pm 0.47^*$	$0.60 \pm 0.04^*$
对照组						
疗前	30	7.59 ± 1.02	12.96 ± 1.12	1.97 ± 0.12	2.54 ± 0.61	0.54 ± 0.07
疗后	30	$6.36 \pm 0.88^*$	11.09 ± 1.04	$1.89 \pm 0.14^*$	2.10 ± 0.48	0.55 ± 0.10

注:与本组治疗前比较,* $P<0.05$,** $P<0.01$;与对照组治疗后比较, $\Delta P<0.05$, $\Delta\Delta P<0.01$

杏贝黛蛤散治疗慢性支气管炎28例

作者: [范云鹏](#)
作者单位: [内蒙古赤峰市喀喇沁旗医院, 024400](#)
刊名: [中国民间疗法](#)
英文刊名: [CHINA'S NATUROPATHY](#)
年, 卷(期): 2004, 12(11)

引用本文格式: [范云鹏](#) [杏贝黛蛤散治疗慢性支气管炎28例](#)[期刊论文]-[中国民间疗法](#) 2004(11)